8.6.1. 환자치료영역 환경관리

제 정 일	1997.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	감염관리실				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 8.6 환자치료영역 환경관리 JCI Standard 7th Edition: PCI.1~15

제1조 (목적)

1. 의료관련 감염발생을 예방하기 위해 환자치료영역의 청소 및 소독을 적절하게 수행하고 환경을 관리하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 환자치료영역의 청소 및 소독
   1) 환경관리인에 대한 교육과 감독은 환경관리 담당부서(사무팀, 경영지원팀 등)에서 주관하며 교육 내용에는 청소방법, 소독제의 종류 및 사용방법, 청소용구 관리, 개인보호구 사용 등에 대한 내용을 포함한다.
   2) 청소구역: 환자치료영역이 아닌 행정사무실, 회의실 등
   3) 소독구역
      (1) 침습적 행위를 수행하는 구역: 수술실, 중재적 치료실, 중환자실, 응급진료센터, 인공신장실 등
      (2) 소독이 필요한 환경: 병동, 외래, 검사실, 화장실 등
      (3) 환자치료영역이 아닌 환경이라도 혈액, 체액, 분비물, 배설물의 오염이 발생한 경우 소독제를 이용하여 청소한다.
   4) 청소 및 소독주기
      (1) 병실바닥 및 화장실: 1일 2회 이상
      (2) 창문: 주 1회 이상
      (3) 환자 간 커튼: 정기적으로 또는 눈에 띄는 오염이 있을 때, 감염성질환 환자가 이동하거나 퇴원할 때
      (4) 침대 및 침요: 눈에 띄는 오염이 있을 때, 환자가 퇴원할 때
      (5) 벽, 블라인드: 눈에 띄는 오염이 있을 때, 블라인드는 최소 2개월에 1회
      (6) 병실은 매일 청소하며, 병실 내의 접촉빈도가 높은 곳(문손잡이, 침상난간, 스위치 등)은 더 자주 청소, 소독한다.
      (7) 욕실과 화장실, 환자 휴게실과 같이 병동 내 공용으로 사용하는 표면은 소독제로 매일 청소한다.
      (8) 환자가 퇴원 및 병실을 이동한 경우 소독제로 청소한다.

(9) 수술실, 고위험 침습적 시술실, 중환자실, 신생아중환자실, 검체를 다루는 검사실 등은 매일 소독제를 이용하여 청소한다.

5) 청소 및 소독 시 주의사항

(1) 연무 또는 에어로졸을 생성하거나 먼지를 분산시키는 청소나 소독방법은 피한다.

(2) 개봉한 소독제는 오염되지 않도록 관리한다.

(3) 세제나 환경소독제를 사용하는 용기는 재사용하지 않으며, 만약 용기를 재사용하는 경우 세척 후 건조시켜 보관한다.

(4) 환경소독제는 제품 설명서에 따라 희석농도, 사용기간, 사용기한일 등을 준수하여 사용한다.

6) 청소용구 및 소독용구 관리

(1) 청소카트는 표준지침에 따라 청결하게 유지한다.

(2) 일회용 소독티슈나 세척 · 소독한 걸레를 사용한다.

(3) 사용한 걸레는 환경소독제로 세척하고 건조 후 재사용한다.

(4) 매일 일과 후에 정리정돈하고 환경소독제로 표면을 닦는다.

(5) 진공청소기를 사용할 경우에는 HEPA 필터가 장착된 것을 사용한다.

7) 직원의 개인보호구 착용

(1) 청소 및 소독 과정에서 감염질환이나 소독제 노출을 예방하기 위하여 적절한 개인보호구(장갑, 가운, 마스크, 보안경 등)를 착용한다.

(2) 격리실 청소 시에는 격리표식에 제시된 개인보호구를 반드시 착용하고 시행한다.

2. 환자치료영역의 물관리

1) 재활치료실 수치료실

(1) 환자관리

① 모든 환자는 수조에 들어가기 전 비누를 사용하여 샤워한 후 들어간다.

② 다음과 같은 환자들은 물을 오염시킬 수 있으므로 수치료 시설 사용을 제한하거나 치료순서를 고려한다.

a. 변실금 환자

b. 개방된 창상이나 치유되지 않는 장루(stoma)를 가진 환자

c. 국소적 감염이 의심되는 피부질환을 가진 환자

(2) 물 관리

① 수치료에 사용하는 물은 다층복합 여과기를 사용하고 역세척 시스템을 통해 매일 관리한다.

② 수조의 물, 모래와 활성탄은 정기적으로 교체한다.

③ 연 2회 수질검사 전문기관에 수질검사를 의뢰한다. 수질검사방법은『먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙』에 따르며, 수질기준은『체육시설의 설치.이용에 관한 법률 시행규칙(2024. 8. 28.) [별표 6] 안전.위생 기준(제23조 관련)』에 따른다(pH5.8-8.6, 유리잔류염소 0.4-1.0㎎/L).

(3) 그 외 세부사항은 [감염관리지침] Ⅶ. 부서별 감염관리_12. 재활치료실에 따른다.

2) 치과 유닛체어

(1) 수관물빼기

① 매일 시작 전과 일과 후 Unit chair의 수관에서 물을 뺀다.
② 환자진료 시 물이 나오는 장비를 사용한 경우에는 환자 치료가 끝나자마자 적어도 20~30초간 물과 공기를 빼낸다.

(2) 수관소독: 최소한 4주에 1번은 시행해야 한다.

(3) 수관미생물검사
① 정기적으로 실시하고 필요시 추가 검사를 실시한다.
② 기준치 이상의 세균이 검출된 chair는 사용을 즉시 중단하고, 수관 소독을 실시한 후 재검사를 실시한다.

(4) 그 외 세부 사항은 [감염관리지침] Ⅸ. 환경관리_7. 치과 유닛체어에 따른다.

3) 인공신장실: 정기적으로 RO수 수질관리를 실시한다.

(1) 투석기계에 공급되는 물은 일반적인 물과는 분리되어 공급해야 하며, 발열물질(pyrogen)의 감소를 위하여 여과나 역삼투압 방식을 거쳐야한다.

(2) 투석액은 세균과 중금속이 없는 여과수여야한다.

(3) 투석액과 투석용수는 매월 1회 정기적으로 배양검사(미생물 수를 계산) 및 내독소 검사를 진행하며 세부사항은 [감염관리지침] Ⅶ. 부서별 감염관리_11. 인공신장실에 따른다.

(4) 미세물질 검사: 년 1회 주기적으로 미세물질 검사를 시행한다.

4) 음용수 관리

(1) 조리장 내: 음용수는 수돗물 사용을 원칙으로 하며, 정기적으로 실시하는 수질검사결과를 확인한다.

(2) 정수기 관리
① 정수기 사용부서 또는 관리부서에서는 정수기 토출구의 오염이 발생하면 즉시 닦아 관리한다.
② 조유용 정수기는 주 1회 토출구를 분리하여 세척제로 세척한다.
③ 총무팀은 먹는물 관리법에 의거하여 관리업체에서 정기적으로 filter 교체, 내부소독 및 수질 평가를 진행하는지 점검한다.
④ 사용부서에서는 정수기 표면의 청결을 유지하고 관리내용이 관리카드에 잘 기록되는지 확인한다.

제4조 (부록)

1. 감염관리지침

제5조 (참고)

1. 대한의료관련감염관리학회. 의료관련감염관리. 군자출판사, 2023
2. 먹는물관리법 제8조(먹는물공동시설의 관리), 제8조의2(냉・온수기 또는 정수기의 설치・관리)
3. 질병관리본부·대한의료관련감염관리학회. 의료관련감염 표준예방지침. 2017
4. 질병관리청. 의료기관환경표면 청소 및 소독 권고안. 2022
5. 체육시설의 설치•이용에 관한 법률 시행규칙(2024.8.28) [별표 6] 안전•위생 기준(제 23조 관련)
6. 보건복지부. 치과감염관리 표준정책 매뉴얼. 2020

7. CDC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. 2003

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 1997년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)